

Внутрішнє акушерське дослідження

Ви лікар акушер – гінеколог пологового залу. В пологовому залі знаходиться первородна, 20 років. Вагітність 39 тижнів. Пологи - розпочалися своєчасно та продовжуються 12 годин. Відійшли світлі, прозорі навколоплідні води. Пологова діяльність регулярна, перейми по 40-45 с через 1-2 хвилини. Загальний стан роділлі задовільний. Положення плода поздовжнє, спинка плода ліворуч до переду, передлежить голівка, що малим сегментом у вході в малий таз. Серцебиття плода 144 уд./хв. Ви приступаєте до внутрішнього акушерського дослідження.

7. Матеріально-технічне оснащення та параметри програмування манекенів.

Перед входом на станцію повинно бути розташоване клінічне завдання (брифінг).

Приміщення, що імітує робоче місце лікаря акушера- гінеколога пологового відділення, обов'язково повинно включати:

- перелік меблів та іншого обладнання

№ п/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Годинник із секундною стрілкою	1 шт.
4	Прилад для обробки рук (можлива імітація)	1 шт.
5	Манекен-симулятор вагітної жінки	1 шт.
6	Манекен-симулятор плоду	1 шт.
7	Медична кушетка (стіл)	1 шт.

- перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

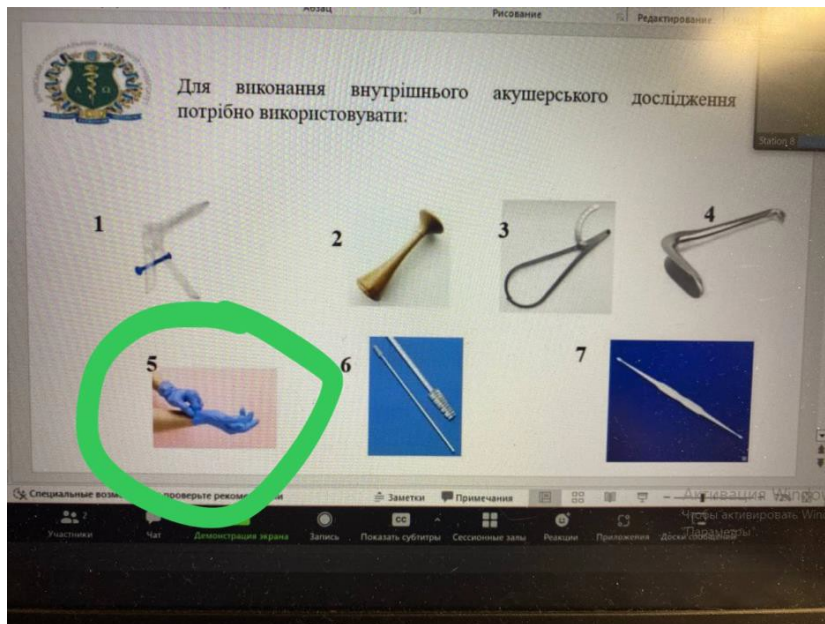
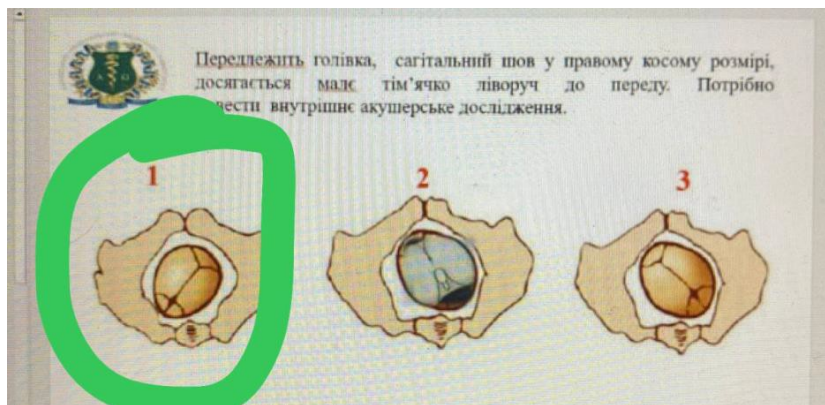
№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Антисептик для обробки рук 5 мл.	1 шт.
2	Контейнер для збору відходів класу А (класу В)	1 шт.

- перелік витратних матеріалів (одноразове використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу
1	Гумові рукавички різних розмірів	2 шт

- симуляційне обладнання

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу
1	Манекен-симулятор вагітної жінки.	1 шт
2	Манекен-симулятор плоду. Реалістичність розмірів плода.	1шт



11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів (ситуаційних завдань)

Алгоритм виконання	Форма представлення	
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Коректне розташування пацієнт-лікар (стоячи навпроти пацієнтки), встановлення контакту з пацієнткою (привітатись, представитися, позначити свою роль).	<i>Сказати Доброго дня. Я лікар акушер-гінеколог.</i>
1.2	Отримати інформаційну згоду на проведення маніпуляції.	<i>Сказати Ви даєте свою згоду на проведення акушерського внутрішнього дослідження (Будемо вважати що згода отримана)</i>

1.3	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	<i>Сказати Будемо вважати, що руки оброблені</i>
2. Виконання навички		
2.1	Визначити стан промежини (висока; низька; деформована рубцями після попередніх пологів) та стан розвитку м'язів. Великим і вказівним пальцями лівої руки розведіть статеві губи.	<i>Виконати – Сказати «Промежина не деформована, тонус м'язів збережений»</i>
2.2	Ввести середній і вказівний пальці правої руки у піхву. Надати характеристику піхвової частини шийки матки: форма, консистенція, наявність рубцевої деформації. Визначити ступінь розкриття шийки матки (в сантиметрах). При наявності згладженої шийки матки – навести опис характеристики її краю (тонкий або товстий; м'який або щільний; добре розтягується або ригідний). При збереженій шийці матки – визначити довжину піхвової частини шийки матки (в см)	<i>Виконати – Сказати «Стінки піхви розтяжні, м'які; шийка матки –розкриття повне, краї не визначаються»</i>
2.3	Визначити наявність плідного міхура його характеристики (випуклий; плоский; напружений; в'ялий); його стан поза і під час перейми: наливається тільки під час перейми, залишається налитим і поза перейми, надмірно напружений або зовсім не наливається під час перейми (плоский міхур).	<i>Виконати – Сказати «Плідний міхур відсутній»</i>
2.4	Визначити передлежачу частину (голівка, сідниці),	<i>Виконати – Сказати «Передлежить</i>

	розташування орієнтирів (сагітального шва та тім'ячок; міжвертельної лінії).	голівка, сагітальний шов у правому косому розмірі, досягається мале тім'ячко ліворуч до переду».
2.5	Встановити відношення передлежачої частини до тієї або іншої площини малого таза (над входом у малий таз; у вході в малий таз; в широкій частині малого таза; у вузькій частині або у виході таза).	Виконати – Сказати «Голівка плода малим сегментом у вході в малий таз, крижова западина вільна»
2.6	Виключити наявність екзостозів та інших новоутворювань в порожнині малого тазу. Встановити глибину склепін та їх особливості. Досяжність мису (досягає чи ні)	Виконати – Сказати «Мис не досяжний. Екзостозів та інших новоутворювань не має»
2.7	Надати характеристику піхвових виділень (слизові, кров'яністі). Зняти рукавиці.	Виконати – Сказати «Виділення слизові»
2.8	Уточнити у пацієнтки її самопочуття.	Сказати « Як Ви себе відчуваєте?» (Будемо вважати – добре)
3. Діагностика (встановити попередній діагноз).		
Вагітність 39 тижнів, I позиція передній вид, головне передлежання. II період пологів.	Сказати	
4.Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Продовжувати ведення пологів природним шляхом	Сказати
4.2	Спостереження за серцебиттям плода	Сказати
4.3	Контроль гемодинамічних показників та загального стану жінки.	Сказати

